EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	87482
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	28-06-2024			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: HERN►N AMALIO MU►OZ PRADO			RUN	: 4.500.283-7
F.Nac	: 05-07-1940	Edad	: 83 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: BRASIL 773			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-19	Fecha Egreso	: 28-06-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. Y44.2-EFECTOS ADVERSOS DE ANTICOAGULANTES

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Bacteremia: E coli.
-Peritonitis Bacteriana ¿primaria?
Sx edematoso secundario:
-Ascitis a tensión (R)
-Derrame pleural izquierdo leve-moderado
Obs Neo Abdominal (Hepático con compromiso portal?) con MT peritoneal
CA próstata con MT pulmonar y ósea
Compromiso neoplásico vena porta: HTP
Discoagulopatía por TACO (R)

AP: HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K65.9-PERITONITIS, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Hospitalizado en contexto de Ascitis a tensión + Derrame pleural izquierdo leve, con compromiso neoplásico.
Durante estancia en servicio de medicina se decide iniciar con paracentesis evacuadora con la cual se obtiene estudio de líquido además de drenaje de 2600cc (limitado por movilización temprana de paciente con pérdida de cateter).
Estudio de líquido 25/06: LDH 258, pH 7.8, Rivalta+++, Glucosa 121, Prot total 3.2, Alb 1.1, GB 615. PMN 75, Mononuclear 25.
GASA: 1.8 (sugerente de hipertensión portal).
Durante estancia, además, inicia con episodio febril por lo que se toma Hemocultivo
Hemocultivo 24/06 por episodio febril y ascenso de parámetros reporta: E. coli sensible ceftriaxona. Tratamiento empírico inicial con carbapenémicos
Se decide estudio extendido en vista de síndrome febril
TC AP 26/06:
Signos que sugieren peritonitis difusa en contexto de severa ascitis secundaria a hipertensión portal determinada aparentemente por lesión proliferativa en el lóbulo hepático izquierdo.
En vista de buena evolución y valoración clínica, se decide continuidad de tratamiento y manejo con HODOM.

INDICACIONES AL ALTA

1. Omeprazol 20mg vo día
2. Ceftriaxona 2gr ev día (2/7)
3. Paracetamol 1gr vo c8h SOS
4. Losartan 50mg vo c12h
5. Tramadol 50mg vo c12h
6. Clonazepam 0.5mg vo c24h
7. Espironolactona 75mg vo c12h
8. Seguimiento HODOM
9. Seguimiento CP

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO